QUESTÕES REUMATOLOGIA (E O RESTO)

Caderno de questões | versão sem respostas pré-preenchidas

Foram preservados todos os 70 enunciados e todas as alternativas disponíveis no arquivo enviado. As respostas inseridas entre os enunciados e os materiais de revisão que não eram questões foram retirados. Grafias e trechos incompletos do documento-base foram mantidos, sem complementação presumida.

QUESTÃO 1

Leia o caso a seguir. Paciente, sexo feminino, 58 anos, apresenta-se no ambulatório com história de dor no joelho direito há anos com piora há 4 meses, associado há rigidez matinal de 25 minutos. Durante a deambulação, há intensificação da dor. Ao exame, o joelho direito apresenta crepitação ao movimento ativo e passivo. Qual hipótese diagnóstica?

a) Atrite Reumatóide
b) Doença por pirofosfato de cálcio
c) Osteoartrite
d) Condromalácia de patela

QUESTÃO 2

Uma paciente de 38 anos relata 2 anos de evolução de dor e aumento de volume das articulações 2ª, 3ª e 4ª metacarpofalangeanas, os punhos e as 3ª e 4ª interfalageanas, de forma aditiva. Relata dificuldade para realizar atividades no período matinal, com rigidez de 2 horas. Nega xeroftalmia, xerostomia, úlceras orais, fotossensibilidade, manchas na pele e fenômeno de Raynaud. Ao exame, observa-se artrite das articulações envolvidas e desvio ulnar bilateral. Qual dos achados abaixo não é esperado para o caso?

a) Radiografia com erosão subcondral
b) Fator reumatóide positivo
c) VHS elevado
d) Acometimento da coluna lombar

QUESTÃO 3

AAS, 28 anos, comparece ao consultório queixando-se de emagrecimento, dores no corpo com piora progressiva nos últimos 2 meses. Nega sintomas neurológicos, respiratórios, urinários e gastrointestinais. Relata muita astenia, dor em joelhos, tornozelos e edema nos tornozelos. Ao exame, bom estado geral, mucosas moderadamente descoradas e úlceras orais. Traz radiografia de tornozelo normal, HB de 9 g/dL, HT de 26%, PLAQ de 90.000, LEUCO de 2000, EAS com proteínas 2+. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e quais os exames para auxiliar na sua confirmação.

a) Artrite reumatóide. ANTI CCP e VHS
b) Lúpus Eritematoso Sistêmico. Anticorpo antinuclear e Anti-DNA
c) Síndrome de Sjögren. Fator reumatóide e Anti-Ro
d) Hepatites virais. Sorologias virais e pesquisa de crioglobulinemia

QUESTÃO 4

O equilíbrio entre agentes anabólicos e catabólicos determina a homeostase, e um desequilíbrio entre estes agentes, com predomínio dos catabólicos, ocasiona a degradação cartilaginosa observada na osteoartrite. Com relação à resposta catabólica dos condrócitos, a seguinte alteração é descrita:

a) Diminuição da síntese de proteoglicanos
b) Diminuição da síntese de metaloproteases
c) Aumento da síntese do inibidor tecidual do plasminogênio

d) Aumento da síntese de colágenos tipo II e IX

QUESTÃO 5

“A doença do manguito rotador pode se desenvolver apenas como tendinite ou evoluir para a ruptura”. Nesse contexto, torna-se imprescindível a realização de testes específicos que identifiquem a tendinite e de testes que avaliem a integridade dos tendões. Dentre os testes utilizados para avaliação da integridade dos tendões, incluem-se:

a) Neer e Hawkins
b) Palm-up test e Yergason
c) Jobe e Patte
d) Gerber e Yocum

QUESTÃO 6

VSB, sexo feminino, 32 anos, é encaminhada para o ambulatório de reumatologia em uso de anti-inflamatórios, com dor intensa na mão direita. Relata que não gosta de atividades físicas e que fica muitas horas seguidas no uso de computador, tablet ou celular. O possível diagnóstico é a tenossinovite estenosante de Quervain, que abrange o primeiro compartimento dorsal (tendões do abdutor longo e do extensor curto do polegar). Assinale o teste adequado para sua confirmação:

a) Thompson
b) Tinel
c) Finkelstein
d) Cosen

QUESTÃO 7

Os auto-anticorpos devem ser solicitados nos cenários em que se suspeita de uma doença inflamatória imunomediada. A dosagem positiva de anticorpos anti-DNA ss e anti-SM tem maior especificidade para o diagnóstico de:

a) LES
b) Doença de Behçet
c) Doença Mista do Colágeno
d) Dermatopolimiosite

QUESTÃO 8

Durante a expansão cutânea realizada para reconstrução de uma sequela de queimadura, o que podemos observar na área tecidual operada?

a) Atrofia da derme
b) Hipertrofia da epiderme
c) Formação de cápsula fibrosa em volta do expansor
d) Todas estão corretas

QUESTÃO 9

Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopecia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?

a) O menor número de procedimentos com anistia geral
b) O menor número de consultas clínicas hospitalares
c) O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo

d) A reconstrução pode ser terminada rapidamente

QUESTÃO 10

Paciente, 38 anos, masculino, tem acidente de carro e chega ao PS queixando-se de muita dor na coluna. Logo após o exame físico, é feito a hipótese de fratura de coluna toracolombar, que é confirmado pelo RX de coluna torácica e lombar. É considerado critério de instabilidade na fratura de explosão de coluna toracolombar:

a) Cifose > 10º
b) Acunhamento > 20º
c) Déficit neurológico
d) Destruição da coluna média

QUESTÃO 11

Os primeiros cuidados no trauma de extremidades devem ser feitos pelo protocolo PRICE, no qual é INCORRETO:

a) P significa proteção
b) R significa repouso
c) I significa imobilização
d) C significa compressão leve

QUESTÃO 12

Paciente após acidente motociclístico, apresenta fratura exposta de membro superior esquerdo com sangramento abundante. Para se estancar uma hemorragia, devemos realizar a seguinte sequência:

a) Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, pinçamento dos cotos vasculares e torniquete
b) Elevação do membro, compressão da artéria proximal, compressão direta do ferimento, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares
c) Compressão direta do ferimento, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares, elevação do membro
d) Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares

QUESTÃO 13

Paciente, sexo feminino, 24 anos, submetida à plástica mamária (mastopexia com prótese) há 90 dias e queixa-se da qualidade da sua cicatriz. Ela refere que apresenta ardência local eventualmente. Ao exame físico da cicatriz, encontra-se com coloração avermelhada, de consistência pouco mais endurecida e levemente elevada, porém, não ultrapassando os limites da própria cicatriz. Essa paciente apresenta:

a) Uma cicatriz queloideana
b) Um tumor desmóide
c) Uma cicatriz hipertrófica
d) Um carcinoma basocelular

QUESTÃO 14

Quanto à fratura exposta, temos os seguintes cuidados:

I. Não movimentar o acidentado
II. Imobilizar o local usando talas improvisadas

III. Tentar colocar o osso no lugar, tracionando as extremidades do membro afetado, para que não ocorra maior perfuração de órgãos ou rompimento de veias ou artérias

IV. Amarrar a tala com tiras de pano, em lugares acima e abaixo do local fratura até a vítima ser encaminhada para o hospital mais próximo

O item totalmente INCORRETO é: _____

QUESTÃO 15

Paciente, 32 anos, sexo masculino, foi vítima de queda de bicicleta. Foi socorrido queixando-se de muita dor e incapacidade movimentar ombro e cotovelo esquerdo. Consegue movimentar punhos e dedos. Levado ao hospital, o médico já suspeito de fratura de úmero, confirmado pela radiografia que mostrou uma fratura intra-articular. Nos casos de fraturas com comprometimento articular do úmero, o tratamento pode ser conservador, caso seja um desvio menor que:

a) 2 mm
b) 2 graus
c) 5 graus
d) 5 mm

QUESTÃO 16

No atendimento imediato ao traumatizado de face, a prioridade absoluta é:

a) Proteger a coluna cervical
b) Reposição volêmica adequada
c) Estabelecer via aérea adequada
d) Colocar o paciente em prancha longa

QUESTÃO 17

Mulher, 42 anos, jogando beach tenis, apresenta ao saltar para uma jogada, dor importante no pé e panturrilha ao pisar novamente no chão. No diagnóstico de trauma de extremidades é correto afirmar:

a) Fratura é uma incongruência articular
b) Luxação é uma lesão direta das partes moles ou osso com hematoma
c) Entorse é uma solução de continuidade do osso
d) Lesão miotendínea é uma impotência funcional por ruptura

QUESTÃO 18

Homem com aumento de edema de joelho foi prescrito AINE e começou a se queixar de epigastralgia. Para o edema de joelho foi passado um diurético que causou hipocalemia, sendo administrado K+, o que piorou epigastralgia. (tem uma sequência de medicamentos e efeitos adversos). Como chamamos esse efeito:

a) Efeito dominó
b) Prescrição em cascata
c) Interação medicamentosa
d) Ineficácia Terapêutica

QUESTÃO 19

O que deve ser EVITADO na desprescrição:

a) Retirar medicamentos preventivos independente da expectativa de vida
b) Retirar medicamentos sintomáticos, mesmo que sintomas já tenham melhorado
c) Retirar vários medicamentos inapropriados ou de alto risco de uma só vez

d) Retirar medicamentos psicotrópicos reduzindo a dose lenta e gradualmente

QUESTÃO 20

Mulher, 78 anos, diabética, perdeu 6kg em 4 meses, apresenta fraqueza, fadiga, dificuldade em subir escadas. Ao teste de preensão palmar obteve resultado de 10kg. Circunferência de panturrilha: 31cm. No caso em questão a paciente apresenta:

a) Provável sarcopenia
b) Sarcopenia confirmada
c) Não apresenta sarcopenia
d) Dados insuficientes para diagnóstico

QUESTÃO 21

Queimadura indolor, aspecto polvilhado, vermelho vivo, nacarado, sem bolhas. Classificação?

a) 1º grau
b) 2º grau sup.
c) 2º grau prof.
d) 3º grau

QUESTÃO 22

Masc., 75, CA de próstata há 2 anos, finalizou TTO com QT. Prostatectomia. Lombalgia contínua, sem fator de melhora ou piora, sem irradiação p/ MMII. Não melhorou com fisioterapia nem relaxante muscular. A dor piorou.

a) Imagem, ... dor compressiva.
b) Investigar metástase para coluna
c) RX de coluna (+S e +E)
d) Metástase para coluna é pouco provável.

QUESTÃO 23

Mulher de 72 anos com osteoporose. Após avaliação médica foi diagnosticado sarcopenia. Quais os critérios para este diagnóstico?

a) Diminuição da massa muscular e diminuição da força
b) Diminuição da força muscular e alto perfil físico
c) Massa muscular normal e diminuição das enzimas musculares
d) Fraqueza muscular e elevação das enzimas musculares

QUESTÃO 24

Homem de 80 anos com osteoartrite no joelho direito em uso de bengala. Quais são as orientações para este paciente?

a) Durante a marcha, a bengala deve ser posicionada no degrau no membro superior esquerdo
b) Para descer uma escada, a bengala deve ser posicionada no degrau, primeiramente. Então, deve-se apoiar o MIE e, finalmente, o MDF, o qual suportará o peso do corpo.
c) Para levantar de uma cadeira, a bengala deve ser posicionada na frente do corpo, primeiramente. Em seguida, deve-se apoiar sobre a mesma inclinando o corpo para frente e levantar.
d) Para deambular, a bengala deve avançar simultaneamente com o membro inferior esquerdo.

QUESTÃO 25

Homem de 27 anos refere dor e edema em joelho D há 4 semanas associado a inchaço bilateral dos dedos. Exame mostra artrite no JD, dactilite e exame geniturinário normal. Qual a principal hipótese diagnóstica?

a) Artrite reativa
b) Artrite reumatoide
c) Gota
d) Artrite séptica

QUESTÃO 26

Qual o fármaco padrão para o tratamento de AR (artrite reumatoide)?

a) Sulfassalazina
b) Leflunomida
c) Difosfato de cloroquina
d) Metotrexato

QUESTÃO 27

A oesteoporose é uma enfermidade caracterizada por redução na densidade mineral óssea e aumento no risco de fraturas. Sobre essa doença, é correto afirmar

a) A atv física de impacto deve ser evitada, pelo risco de fratura
b) A teriparatida é a droga de escolha no tto da osteoporose com fratura
c) A densitometria óssea deve ser realizada em todas as mulheres, a partir dos 40 anos
d) Quando indicado o uso do alendronato, não é necessário prescrever cálcio e vitamina

QUESTÃO 28

Paciente, fem, 23 anos, deu entrada no P.S. do HC, referindo falta de ar há 1 mês, com pior há 3 dias. Relatava dor e edema nas articulações das mãos (IFPs e punhos) e joelhos há 6 meses. Referia também edema de MMII e urina espumosa. Ao exame físico: BEG, hipocorada +/4+, dispneica, afebril, PA 140/90 mmHg. ACV: RCR, 2T, BNF, sem sopro, FC 100 bpm. AR: MV diminuído em base de hemitórax D. Abdome: flácido, indolor a palpação sem visceromegalias. Articular: Edema e dor a palpação e movimentação das 2as e 3as e 4as IFPs e joelhos. Edema de MMII 2+/4+. Ex. labs: Hemograma: Hb = 8,0, Leucocitos : 2000; Plaquetas: 50.000; VHS : 80 m/h (VR<20); ASO : 540 * (VR<200); Fator reumatoide : 10 UI/ml (VR <20); FAN : 1/640 nuclear pontilhado grosso. Eletroforese de proteínas: hipoalbuminemia e gamopatia policlonal. A radiografia de tórax com derrame pleural à D. Nesse caso, a melhor hipótese diagnóstica é:

a) LES
b) AR
c) Sjögren
d) Artrite psoriásica

QUESTÕES DISCURSIVAS E DE RESPOSTA CURTA

QUESTÃO 29

Poliartrite acomete quantas articulações?

QUESTÃO 30

Gota pertence à qual diagnóstico sindrômico?

QUESTÃO 31

Aspecto radiológico da artrite psoriásica?

QUESTÃO 32

Tratamento medicamentoso da espondilite anquilosante após falha em 3 meses de AINEs?

QUESTÃO 33

Caso sugestivo de LES, qual exame solicitar?

QUESTÃO 34

Demências no idoso e suas etiologias?

QUESTÃO 35

Prevenção de quedas em idosos

QUESTÃO 36

Ossos mais fraturas em situações que o indivíduo cai do telhado de pé?

QUESTÃO 37

Tratamento pé torto congênito?

QUESTÃO 38

Vantagem do autoenxerto?

QUESTÃO 39

Critérios do fenótipo de fragilidade no idoso da Linda Fried.

QUESTÃO 40

Como conduzir um caso de trauma raquimedular para evitar lesões secundárias?

QUESTÃO 41

Critérios para serem observados ao debridar musculatura em fraturas expostas.

QUESTÃO 42

Como conduzir um caso de grande queimado em criança?

QUESTÃO 43

Síndromes geriátricas.

QUESTÃO 44

Mulher de 45 anos, branca, professora, procura o ambulatório com queixas de dor e edema em mãos e punhos, associada a rigidez matinal de noventa minutos, há pelo menos 5 minutos. Nega outras queixas. Ao exame físico, observa-se artrite de punhos; 2a e 3a metacarpofalangeanas, bilateralmente; 2a/3a/4a interfalangeanas proximais, bilateralmente; atrofia de interósseos; 2o/3o dedos em pescoço de cisne, bilateralmente. Traz os seguintes exames: Hemograma normal; fator reumatoide positivo; FAN negativo; VHS e PCR elevadas. Quais as alterações radiográficas esperadas nesse caso?

QUESTÃO 45

JR, 49 anos, branca, professora, procura o ambulatório com queixa de dor disseminada em todo o corpo, ansiedade, nervosismo, insônia e irritabilidade. Interrogatório sintomatológico: refere obstipação intestinal crônica. Ao exame físico, apresenta 14 tender points e não apresenta artrite ou deformidades articulares. Traz os seguintes exames: hemograma normal, fator reumatoide negativo, FAN negativo, TSH normal, VHS e PCR normais. Sobre esse caso, pode-se afirmar que:

QUESTÃO 46

Homem de 28 anos relata dor lombar, que se iniciou há fez anos, que piora com o repouso e melhora com o movimento, associada a rigidez matinal de uma hora. Informa também dor nos ombros e na coluna cervical. Não está conseguindo dormir a noite. Ao exame físico, observa-se retificação lombar e teste de Patrick Fabere positivo, bilateralmente. Qual o provável diagnóstico e exame a ser solicitado, nesse caso?

QUESTÃO 47

Homem de 59 anos, refere dor em joelhos, cotovelos e dorso dos pés, de início há mais de 10 anos. Relata que no início a dor era episódica e acometia principalmente os pés (pododáctilos e tornozelos), mas nos últimos dois anos está quase constante, com crise a cada dois meses, associada ao aparecimento de nodulações, nos cotovelos e nos pés. Atualmente, está sem crise. Faz uso constante de anti-inflamatório não hormonal. Traz os seguintes exames complementares: IIb = 14,0 g/dL; leucócitos = 5.000/mm3 (diferencial normal); plaquetas = 180.000/mm3. VHS = 50mm. Ureia/creatinina/TGO/TGP/Glicemia -= normais. RX pés = lesão em saca bocado nas primeiras MTFs, bilateralmente, e nos ossos do tarso. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta para esse caso?

QUESTÃO 48

Mulher de 58 anos, profissão de salgadeira, relata parestesia no primeiro, segundo e terceiro dedos da mão direita. Após a avaliação, o acadêmico de medicina concluiu que a paciente tinha síndrome do túnel do carpo. Que manobra de exame físico auxiliou o acadêmico a chegar a essa conclusão?

QUESTÃO 49

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória, autoimune, com formação de imunocomplexos, que teve seus critérios de classificação reavaliados em 2012. De acordo com essa reavaliação, fazem parte dos novos critérios da doença:

QUESTÃO 50

A osteoartrite é uma doença caracterizada por dor articular e limitação dos movimentos. Radiologicamente, caracteriza-se por:

QUESTÃO 51

Paciente masc, 23 anos, natural e procedente de Goiânia – GO, administrador de empresa, procurou o ambulatório com quadro de dor e aumento de volume de tornozelos e joelho D, de início há 1 mês. Referia antecedente de uretrite, tratado por urologista, há 2 meses. Ao exame físico, apresentava artrite de tornozelos (D e E) e joelho D; e hiperemia conjuntival à D. Ausência de lesões cutâneas palmo-plantares. A principal hipótese diagnóstica nesse caso é:

QUESTÃO 52

Paciente fem, 68 anos, natural e procedente de Abadiânia, passadeira de roupas, procura o ambulatório com queixa de dor em mãos e ombros, de início há 3 anos, que melhora com o repouso e piora com o esforço físico. Nega sintomas concomitantes. Ao exame físico, apresenta dor e limitação aos movimentos do ombro D, nodulações dolorosas à palpação em IFPs e IFDs, e dor aos movimentos do punho D. Quais exames complementares são essenciais na investigação diagnóstica?

QUESTÃO 53

Paciente masc, 43 anos, natural e procedente de Goiânia, bancário, procurou assistência médica com dor e edema no joelho D há 2 dias. Referia quadro semelhante no tornozelo esquerdo há 6 meses. Antecedente de hipertensão arterial sistêmica em uso de HCTZ. Relatava etilismo e tabagismo. Ao exame físico, apresentava eritema, aumento de volume, calor e dor em joelho D. Qual deve ser o melhor esquema terapêutico após feita a principal hipótese diagnóstica?

QUESTÃO 54

Paciente fem, 18 anos, natural e procedente de Trindade, procurou o CAIS referindo dor nas interfalangeanas proximais e punhos há 6 meses, com piora há 2 meses, quando iniciou edema das articulações referidas, rigidez matinal de 1 hora, febre, tosse seca e dor torácica ventilatório dependente. Relatava antecedente de púrpura trombocitopênica há 1 ano quando teve que usar corticoide. Trazia um hemograma com anemia normocítica e normocromica sem outras alterações. Quais exames complementares são necessários na investigação da principal hipótese diagnóstica?

QUESTÃO 55

Em uma paciente de 43 anos, com poliartrite crônica, de acometimento de mãos e pés, procedente da região central do Brasil, além da investigação para artrite reumatoide, é fundamental o diagnóstico diferencial com:

QUESTÃO 56

São considerados fatores de risco para osteoporose:

QUESTÃO 57

No diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, a hiperflexão forçada dos punhos pode desencadear os sintomas de dor e parestesia no território do nervo mediano. Tal manobra é conhecida como teste de:

QUESTÃO 58

A manobra de Patrick-Fabere, quando positiva, indica:

QUESTÃO 59

Segundo o Consenso Brasileiro de Artrite Reumatoide, são fatores que indicam pior prognóstico em pacientes com artrite reumatoide:

QUESTÃO 60

Em um paciente com FAN positivo, a possibilidade de ele apresentar lúpus eritematoso sistêmico é mais relevante, na presença de auto-anticorpo:

QUESTÃO 61

Paciente masc 22 anos, branco, lavrador, natural de sorriso MT, procedente de rio verde, procura o HC com queixa de dor lombar à direita, de início há 2 anos que piora com o repouso e no período noturno, e melhora durante o dia. Relata rigidez matinal de até meia hora. No IS, refere dor em calcanhares, intermitente e alternante, há 6 meses. Há uma semana, apresentando dor no olho esquerdo, fotofobia e diminuição da acuidade visual. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

QUESTÃO 62

Paciente, fem, 52 anos, negra, serviços gerais, natural de ouro preto MG, procedente de mineiros, refere dor em mãos, ombros, joelhos e coluna lombar, de início há 3 anos e piora progressiva. Relata inchaço dos joelhos, principalmente quando permanece longos períodos de pé. Ao exame físico: ausência de artrite; presença de nodulações, de consistência endurecida, em IFPs e IFDs; crepitação em joelhos, principalmente à direita; limitação aos movimentos do segmento lombar. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

QUESTÃO 63

Paciente, masc, 45 anos, refere dor e edema na 1a metatarsofalangeana a direita iniciada na madrugada (há 8 h). Relata episódios anteriores semelhantes em 1a metatarso falangeanas, tornozelos e dorso dos pés. Traz uma dosagem de ácido úrico sérico de 11 mg/dl realizada há um mês. É hipertenso, em uso de HCTZ 25 mg/d, anlodipina 5mg/d e AAS 100mg/d. Nesse caso, a conduta terapêutica inicial é:

QUESTÃO 64

Paciente fem, 49 anos, branca, professora, natural e procedente de Goiânia, procurou o OS/HC com queixas de dor nas juntas. Referiu início dos sintomas há 4 meses, com dor e edema em punhos, 2o/3o metacarpofalangeanas (bilateralmente) e joelhos. O quadro é mais acentuado pela manhã, com alivio após atividade física, associado à rigidez matinal de 2 horas. Negava outras queixas e comorbidades. Exame físico: artrite em joelhos, punhos e 2o/3o metacarpofalangeanas(bilateralmente). Nódulo subcutâneo em face extensora de cotovelo direito. Labs: Hemograma normal, VHS 56 mm (1o hora), fator reumatoide 173 UI/ml (normal < 20). Rx de mãos: erosão no processo estiloide da ulna bilateralmente. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

QUESTÃO 65

Paciente, 64 anos fem, doméstica, procurou o ambulatório com queixas de dor em joelhos, iniciada há 6 meses. Refere piora do quadro com atividade física e alívio com repouso. Nega rigidez matinal, edema articular e calor local. Exame físico: crepitações grosseiras em joelhos, sem sinais de artrite ou ruptura ligamentar. Peso: 87 kg, altura: 1,54m; trazia consigo radiografia de joelhos revelando esclerose subcondral, redução do espaço articular e osteofitose. Assinale a principal hipótese diagnóstica para o caso:

QUESTÃO 66

Paciente, 25 anos, fem, negra, auxiliar de escritório, relata dor e edema em IFPS das mãos, punhos e tornozelos há 2 meses, seguida de queda de cabelo, úlceras orais e fotossensibilidade. Traz um FAN 1/640 pontilhado grosso e VHS = 45 mm. Baseado na principal hipótese diagnóstica qual a medicação deve ser iniciada para a paciente?

QUESTÃO 67

Paciente, masc, 45 anos, foi despertado durante a madrugada por dor súbita no joelho direito associado a edema, calor e rubor. Negava febre. Relatava episódios prévios semelhantes, porem em primeira metatarsofalangeana. Etilista diário. Sedentário. A principal hipótese diagnóstica e a conduta imediata seriam:

QUESTÃO 68

Paciente, 24 anos, fem, jogadora de basquete, iniciou há cerca de 3 meses com queixa de dor em ombro direito, continua, pior a movimentação, aliviada parcialmente com uso de anti-inflamatórios. Procurou o reumatologista sendo evidenciado piora da dor com a elevação contra a resistência do braço direito (sinal de Neer positivo). O tendão possivelmente acometido é:

QUESTÃO 69

Paciente, 82 anos, sexo feminino, do lar, natural e procedente de Goiânia, procura assistência medica para avaliação de densitometria óssea. Tabagista há 60 anos. Nega etilismo. Nega doenças pessoais. G IX; P VIII; A I. Após avaliação da densitometria, o médico assistente conclui por osteoporose. Neste caso, a prescrição médica deverá incluir:

QUESTÃO 70

A espondilite anquilosante, é uma doença inflamatória que acomete o esqueleto axial. Quais as alterações encontradas da radiografia da coluna lombar na espondilite anquilosante?

GABARITO REVISADO E COMENTADO

Análise independente, baseada nas questões e em diretrizes; respostas previamente preenchidas no arquivo foram ignoradas. Asterisco (*) indica alternativa mais provável que exige ressalva técnica. “Sem gabarito inequívoco” não é omissão: indica impossibilidade de validar resposta única.

01 C	**08** D	**15** A*	**22** B
02 D	**09** C	**16** C	**23** A
03 B	**10** C	**17** D	**24** A*
04 A	**11** C	**18** B	**25** A
05 C	**12** D*	**19** C*	**26** D
06 C	**13** C	**20** A	**27** SEM GABARITO INEQUÍVOCO
07 A	**14** III	**21** D*	**28** A

Ressalvas de elaboração: questões 10, 12, 15, 19, 21, 22, 24 e 27 apresentam ambiguidade, incompletude ou formulação excessivamente absoluta. A questão 14 é respondida por item romano, sem alternativas a–d.

QUESTÕES OBJETIVAS – ANÁLISE ALTERNATIVA POR ALTERNATIVA

Questão 01 — resposta: C

a. Artrite reumatoide costuma causar poliartrite inflamatória, sinovite e rigidez prolongada; não é a melhor explicação para dor mecânica isolada com crepitação.

b. Doença por depósito de pirofosfato pode afetar joelhos, mas o caso não descreve crise aguda ou condrocalcinose que a favoreça.

c. CORRETA. Dor que piora com a carga, crepitação e rigidez matinal breve são características de osteoartrite do joelho.

d. Condromalácia costuma causar dor femoropatelar anterior, especialmente ao subir escadas ou agachar, e não explica tão bem o conjunto descrito.

Referências pertinentes: R17, R9.

Questão 02 — resposta: D

a. Erosões marginais/justa-articulares podem ocorrer na artrite reumatoide estabelecida, embora 'subcondral' seja termo impreciso para seu padrão clássico.

b. Fator reumatoide pode ser positivo, mas não é obrigatório nem isoladamente diagnóstico.

c. VHS pode elevar-se por inflamação sinovial persistente, ainda que também possa ser normal.

d. CORRETA (não esperado). A artrite reumatoide tipicamente poupa a coluna lombar; quando acomete coluna, predomina a região cervical.

Referências pertinentes: R1.

Questão 03 — resposta: B

a. Artrite reumatoide isolada não explica tão bem a combinação de pancitopenia, úlceras orais e proteinúria.

b. CORRETA. Citopenias, úlceras orais, artralgias e provável acometimento renal favorecem LES; FAN, anti-dsDNA, complementos e avaliação renal auxiliam.

c. Sjögren costuma predominar com secura ocular e oral e não explica a apresentação multissistêmica tão bem.

d. Hepatites podem causar artralgia e alterações sistêmicas, mas o conjunto clínico favorece mais LES; sorologias caberiam conforme exposição e diferencial.

Referências pertinentes: R2, R20.

Questão 04 — resposta: A

a. CORRETA. Na resposta catabólica há perda de matriz e menor síntese/retensão de proteoglicanos, contribuindo para degradação cartilaginosa.

b. Metaloproteinases que degradam matriz geralmente aumentam, não diminuem.

c. A alternativa menciona 'inibidor tecidual do plasminogênio'; é terminologicamente confusa e não representa a alteração catabólica central. Inibidores de metaloproteinases não caracterizam aumento destrutivo.

d. Colágeno II é componente estrutural da cartilagem hialina; aumento de sua síntese é resposta reparativa, não o marcador catabólico solicitado.

Referências pertinentes: R9.

Questão 05 — resposta: C

a. Neer e Hawkins são testes de impacto subacromial; não demonstram especificamente integridade tendínea.

b. Palm-up/Speed e Yergason avaliam principalmente alterações da cabeça longa do bíceps.

c. CORRETA. Jobe testa principalmente supraespinal, e Patte avalia rotação externa/infraespinal, úteis na suspeita de lesões tendíneas do manguito.

d. Gerber (lift-off) testa subescapular, mas Yocum é teste de impacto; a dupla não corresponde somente a testes de integridade.

Questão 06 — resposta: C

a. Thompson pesquisa ruptura do tendão de Aquiles.

b. Tinel identifica irritação de nervo, como no túnel do carpo; não é teste principal de De Quervain.

c. CORRETA. Finkelstein provoca dor no primeiro compartimento extensor do punho, compatível com De Quervain.

d. Cozen/Cosen é empregado na avaliação de epicondilalgia lateral.

Referências pertinentes: R18.

Questão 07 — resposta: A

a. CORRETA pela presença de anti-Sm, anticorpo de alta especificidade para LES. Ressalva: anti-DNA de fita simples (ssDNA) é pouco específico, ao contrário de anti-dsDNA.

b. Behçet é diagnóstico predominantemente clínico, com úlceras recorrentes e outras manifestações; anti-Sm não é típico.

c. Doença mista do tecido conjuntivo relaciona-se especialmente a anti-U1-RNP, não anti-Sm.

d. Dermatomiosite associa-se a anticorpos miosite-específicos e fraqueza proximal; anti-Sm não a define.

Referências pertinentes: R20.

Questão 08 — resposta: D

a. VERDADEIRA. O estiramento cutâneo pode afinar a derme durante a expansão.

b. VERDADEIRA. Ocorre aumento proliferativo/espessamento epidérmico na expansão tecidual.

c. VERDADEIRA. Uma cápsula fibrosa pode se formar ao redor do expansor como resposta a corpo estranho.

d. CORRETA. Os três fenômenos histológicos descritos podem coexistir durante a expansão.

Referências pertinentes: R10.

Questão 09 — resposta: C

a. A expansão demanda colocação e posterior remoção do expansor; não garante menos procedimentos sob anestesia.

b. O processo requer acompanhamento e insuflações seriadas; não reduz necessariamente o número de consultas.

c. CORRETA. Permite aproximar pele pilosa do couro cabeludo, preservando cobertura com cabelo e melhor compatibilidade estética.

d. A expansão costuma ser gradual por semanas; não representa reconstrução necessariamente rápida.

Referências pertinentes: R10.

Questão 10 — resposta: C

a. Cifose superior a 10 graus, isoladamente, não é critério universal de instabilidade de fratura explosão.

b. Acunhamento de 20 graus isolado tampouco determina necessariamente instabilidade; parâmetros e lesão ligamentar devem ser considerados.

c. MAIS ADEQUADA. Déficit neurológico sugere lesão grave e aumenta a pontuação no TLICS; deve motivar avaliação especializada urgente.

d. A coluna média é frequentemente acometida por definição na fratura explosão; sua lesão isolada não estabelece instabilidade cirúrgica no TLICS moderno. Enunciado usa conceito histórico de Denis.

Referências pertinentes: R13.

Questão 11 — resposta: C

a. P é 'Protection', isto é, proteção.

b. R é 'Rest', repouso relativo.

c. CORRETA (incorreta na sigla). I significa 'Ice' (gelo), não imobilização.

d. C significa 'Compression' (compressão), aplicada sem comprometer a perfusão.

Referências pertinentes: R18.

Questão 12 — resposta: D*

a. A ordem descrita reserva o torniquete para depois de pinçamento de cotos, inadequado no controle inicial de hemorragia de extremidade.

b. A sequência posterga a compressão direta, que é medida de controle imediata.

c. Embora comece com compressão direta, inclui pinçamento indiscriminado e coloca elevação ao final; não reproduz protocolo atual.

d. MAIS PRÓXIMA da sequência didática antiga e provável intenção da questão. Contudo, NÃO é protocolo contemporâneo: diante de sangramento intenso use pressão direta e, se indicado, torniquete rapidamente; não tente pinçar vasos em primeiros socorros nem dependa de elevação/pontos de pressão.

Referências pertinentes: R12.

Questão 13 — resposta: C

a. Queloide ultrapassa os limites da ferida original e pode crescer além deles.

b. Tumor desmoide é lesão fibromatosa profunda, não o aspecto usual de uma cicatriz de 90 dias.

c. CORRETA. Cicatriz hipertrófica é elevada, eritematosa e permanece restrita aos limites da incisão.

d. Carcinoma basocelular não é a explicação típica para elevação linear recente confinada à cicatriz.

Questão 14 — item III (incorreto)

I. I: geralmente apropriado evitar movimentação desnecessária até avaliação da segurança, coluna e risco de lesão adicional; a frase absoluta admite exceções por perigo no local.

II. II: correto imobilizar de maneira cuidadosa e acolchoada, reduzindo deslocamentos.

III. III: INCORRETO como orientação leiga geral. Não se deve tentar reintroduzir osso exposto ou executar manobras de redução sem avaliação e treinamento adequados.

IV. IV: correto fixar talas acima e abaixo da lesão sem apertar excessivamente e verificando circulação distal.

Questão 15 — resposta: A*

a. MAIS ADEQUADA. Desvio articular de até cerca de 2 mm é referência usada em alguns padrões de fratura do úmero, mas o sítio da fratura não foi especificado; conduta real depende também de estabilidade e segmento.

b. Dois graus medem angulação, não o degrau articular solicitado.

c. Cinco graus também medem angulação; não correspondem ao limite em milímetros.

d. Desvio de 5 mm costuma exceder o tolerável em superfícies articulares congruentes.

Questão 16 — resposta: C

a. Proteção cervical é imprescindível e ocorre simultaneamente à abordagem da via aérea, mas não substitui assegurar sua perviedade.

b. Reposição volêmica pode ser essencial se houver choque, mas segue priorização inicial da via aérea.

c. CORRETA. No trauma facial, obstrução por sangue, edema ou fragmentos pode ameaçar rapidamente a vida; manter via aérea com proteção cervical é prioritário.

d. Prancha longa não é a medida imediata prioritária; sua utilização é seletiva e não deve atrasar via aérea.

Referências pertinentes: R12.

Questão 17 — resposta: D

a. Fratura corresponde à perda de continuidade do osso, não à incongruência articular.

b. Luxação é perda completa do contato articular; contusão é trauma de partes moles sem esse deslocamento.

c. Entorse é lesão de ligamentos/cápsula por movimento anormal, não solução de continuidade do osso.

d. CORRETA na formulação geral. Ruptura muscular ou tendínea pode causar perda importante da função; o episódio é sugestivo, inclusive, de lesão do tendão de Aquiles.

Referências pertinentes: R18.

Questão 18 — resposta: B

a. 'Efeito dominó' é expressão coloquial, não a denominação farmacoterapêutica específica.

b. CORRETA. Prescrição em cascata ocorre quando efeito adverso de um medicamento é interpretado como novo problema e tratado com outro fármaco, originando novos eventos.

c. Interação entre fármacos é possibilidade distinta, mas o caso enfatiza o tratamento sucessivo de reações adversas.

d. Ineficácia terapêutica é falta de benefício esperado, não prescrição motivada por efeito adverso.

Questão 19 — resposta: C*

a. TAMBÉM PROBLEMÁTICA: retirar preventivos 'independentemente da expectativa de vida' ignora prognóstico, benefício esperado e riscos; logo também é prática a evitar. A questão é ambígua.

b. Medicamentos sintomáticos podem ser revistos quando sintomas cessam, com vigilância de recidivas e indicação original.

c. RESPOSTA MAIS DIRETA: suspender simultaneamente vários medicamentos dificulta identificar síndrome de retirada ou retorno da doença; prioriza-se retirada escalonada quando possível.

d. A redução lenta de muitos psicotrópicos, quando indicada, é prática prudente para reduzir abstinência e efeitos de rebote; portanto não é o que deve ser evitado.

Referências pertinentes: R14.

Questão 20 — resposta: A

a. CORRETA. Preensão de 10 kg é força baixa para mulher (EWGSOP2: abaixo de 16 kg); indica sarcopenia provável.

b. Para confirmar, é necessário demonstrar quantidade/qualidade muscular reduzida, geralmente com DXA ou bioimpedância validada; perímetro isolado não confirma.

c. A preensão muito baixa refuta ausência de suspeita.

d. Há dados suficientes para classificar sarcopenia PROVÁVEL, embora não para confirmação diagnóstica.

Referências pertinentes: R6.

Questão 21 — resposta: D*

a. Primeiro grau é queimadura superficial, geralmente muito dolorosa, eritematosa e sem bolhas.

b. Segundo grau superficial costuma ser úmido, vermelho, muito doloroso e frequentemente com bolhas.

c. Segundo grau profundo pode ser pálido/avermelhado, menos doloroso e com sensibilidade reduzida; o aspecto descrito não distingue com certeza essa categoria.

d. MAIS PROVÁVEL pela ausência de dor e aspecto nacarado: terceiro grau (espessura total). Ressalva: 'vermelho vivo' é achado atípico isolado e a profundidade requer avaliação clínica da perfusão e sensibilidade.

Referências pertinentes: R11.

Questão 22 — resposta: B

a. Alternativa textual INCOMPLETA ('Imagem, ... dor compressiva'); não se pode julgar sua proposição integral sem inventar o trecho omitido.

b. CORRETA. História de câncer de próstata e dor lombar progressiva persistente exigem investigação de metástase vertebral; avaliar sinais de compressão medular e realizar imagem adequada.

c. Radiografia isolada pode não detectar metástase precocemente; conforme sinais de alerta, RM é exame preferencial, especialmente se suspeita de compressão.

d. A doença neoplásica torna metástase plausível; considerá-la improvável sem investigação é incorreto.

Referências pertinentes: R13.

Questão 23 — resposta: A

a. CORRETA. Redução de força e de massa/qualidade muscular confirma sarcopenia segundo EWGSOP2.

b. Desempenho físico 'alto' não é critério; baixo desempenho indica maior gravidade.

c. Massa normal não confirma sarcopenia, e dosagem de enzimas não integra seus critérios.

d. Elevação de enzimas musculares sugere outras miopatias; não é critério diagnóstico de sarcopenia.

Referências pertinentes: R6.

Questão 24 — resposta: A*

a. MAIS ADEQUADA quanto ao lado: a bengala deve ficar na MÃO ESQUERDA, contralateral ao joelho direito comprometido. A expressão 'no degrau' durante marcha plana é mal redigida.

b. Na descida, bengala e perna comprometida descem primeiro; colocar a perna esquerda sadia antes da direita contraria a técnica usual.

c. Ao levantar da cadeira, o correto é impulsionar-se nos apoios da cadeira, não descarregar todo o peso em uma bengala à frente.

d. Na marcha, bengala esquerda avança junto com a perna DIREITA sintomática, e não junto com a esquerda.

Referências pertinentes: R14.

Questão 25 — resposta: A

a. CORRETA. Oligoartrite assimétrica de membro inferior e dactilite em adulto jovem sugerem espondiloartrite periférica, especialmente artrite reativa; avaliar antecedente infeccioso.

b. Artrite reumatoide costuma cursar com poliartrite simétrica de pequenas articulações; dactilite não é clássica.

c. Gota pode inflamar joelho, porém dactilite e idade tornam artrite reativa mais sugestiva; diagnóstico por cristais exige artrocentese.

d. Artrite séptica permanece diagnóstico importante a excluir com análise sinovial, mas dactilite associada favorece a hipótese da letra A.

Referências pertinentes: R15.

Questão 26 — resposta: D

a. Sulfassalazina é DMARD convencional alternativa em contextos selecionados, não o principal fármaco âncora.

b. Leflunomida é DMARD efetivo, mas usualmente alternativa ao metotrexato.

c. Cloroquina tem uso mais restrito e potencial de toxicidade; não é droga padrão preferencial da AR moderada/alta.

d. CORRETA. Metotrexato é DMARD âncora na artrite reumatoide ativa, salvo contraindicações, com monitorização e ácido fólico.

Referências pertinentes: R1.

Questão 27 — resposta: SEM GABARITO INEQUÍVOCO

a. Atividade física resistida e com carga, adaptada ao risco, costuma ser recomendada; proibição generalizada é incorreta.

b. Teriparatida pode ser preferível em risco de fratura MUITO alto, sobretudo fraturas vertebrais, mas não é obrigatoriamente primeira escolha após toda e qualquer fratura.

c. Não se indica densitometria indiscriminadamente a todas as mulheres desde os 40 anos; rastreio segue idade e fatores de risco.

d. Não é obrigatório SUPLEMENTAR cálcio/vitamina D quando a ingestão alimentar e o estado vitamínico são suficientes; porém devem-se assegurar níveis adequados durante tratamento. O enunciado omite o 'D' e é absoluto, impedindo afirmação universal.

Referências pertinentes: R7, R8, R19.

Questão 28 — resposta: A

a. CORRETA. Artrite, citopenias hematológicas, proteinúria/edema, serosite pleural e FAN alto favorecem LES com possível nefrite; requer investigação urgente.

b. Artrite reumatoide pode causar sinovite e pleurite, mas leucopenia e plaquetopenia importantes e possível acometimento renal favorecem LES.

c. Sjögren não costuma causar esse conjunto sistêmico grave na ausência de manifestações glandulares.

d. Artrite psoriásica costuma estar associada a psoríase, alterações ungueais, entesite ou dactilite; não explica bem pancitopenia e nefropatia.

Referências pertinentes: R2, R20.

QUESTÕES DISCURSIVAS – RESPOSTAS FUNDAMENTADAS

QUESTÃO 29

Resposta: Cinco ou mais articulações.

Comentário: Poliartrite é acometimento de pelo menos cinco articulações; oligoartrite envolve 2 a 4, e monoartrite apenas uma.

Referências pertinentes: R1.

QUESTÃO 30

Resposta: Artrite aguda, frequentemente monoartrite por cristais.

Comentário: A crise típica de gota é uma monoartrite inflamatória súbita (podagra é clássica), mas gota crônica ou crises intensas também podem ser oligo/poliarticulares.

QUESTÃO 31

Resposta: Erosões associadas a neoformação óssea; deformidade 'lápis na taça'.

Comentário: Na artrite psoriásica podem ocorrer erosões periféricas, proliferação óssea periosteal, anquilose e osteólise de falanges; 'pencil-in-cup' é achado clássico, não obrigatório.

Referências pertinentes: R15.

QUESTÃO 32

Resposta: Biológico: inibidor de TNF ou de IL-17, em doença axial persistente ativa com critérios de elegibilidade.

Comentário: Após resposta inadequada a pelo menos dois AINEs e atividade inflamatória objetiva, recomendações ASAS-EULAR permitem TNFi ou IL-17i; JAKi é outra opção selecionada. 'Três meses' isoladamente não basta.

Referências pertinentes: R3.

QUESTÃO 33

Resposta: FAN por imunofluorescência como exame de triagem; associar exames dirigidos.

Comentário: Diante de suspeita clínica de LES, pedir FAN e, para confirmação/caracterização, anti-dsDNA, anti-Sm, C3/C4, hemograma, creatinina, EAS e proteinúria. FAN isolado não confirma LES.

Referências pertinentes: R2, R20.

QUESTÃO 34

Resposta: Principais etiologias: doença de Alzheimer, doença cerebrovascular, demência com corpos de Lewy, demência frontotemporal e apresentações mistas.

Comentário: Classificar por perfil cognitivo, curso temporal e exame clínico; pesquisar causas potencialmente tratáveis de comprometimento cognitivo, como fármacos, hipotireoidismo e deficiência de B12 quando apropriado.

Referências pertinentes: R14.

QUESTÃO 35

Resposta: Prevenção multifatorial: exercício de força e equilíbrio, revisar medicações e causas clínicas, corrigir riscos domiciliares e déficits sensoriais.

Comentário: Avaliar quedas prévias, marcha, visão, hipotensão ortostática, calçados, obstáculos, iluminação e dispositivos auxiliares. Individualizar a intervenção em vez de adotar uma única medida.

Referências pertinentes: R14.

QUESTÃO 36

Resposta: Calcâneos e vértebras toracolombares; tálus também pode fraturar.

Comentário: Queda vertical sobre os pés transmite carga axial, predispondo a fraturas de calcâneo, tálus e por compressão/explosão toracolombar; investigar lesões associadas.

QUESTÃO 37

Resposta: Método de Ponseti.

Comentário: Consiste em manipulações e gessos seriados, frequentemente tenotomia percutânea do Aquiles para equino residual, seguidos de órtese de abdução para prevenir recidiva.

QUESTÃO 38

Resposta: Biocompatibilidade e ausência de rejeição imunológica do enxerto autólogo.

Comentário: Tecido do próprio paciente integra-se bem, sem reação imunológica de aloenxerto; limitações incluem morbidade e disponibilidade da área doadora.

QUESTÃO 39

Resposta: Cinco critérios de Fried: perda ponderal involuntária, exaustão, fraqueza de preensão, lentidão da marcha e baixo nível de atividade física.

Comentário: Três ou mais caracterizam fragilidade; um a dois indicam pré-fragilidade; nenhum, robustez, conforme operacionalização utilizada.

Referências pertinentes: R14.

QUESTÃO 40

Resposta: ABCDE com proteção da coluna, evitar hipóxia e hipotensão e providenciar estabilização, avaliação neurológica e imagem adequadas.

Comentário: Manter alinhamento e perfusão medular, controlar hemorragia e oxigenação; realizar exame neurológico seriado, TC quando indicada e RM em déficits/lesão ligamentar suspeita. Encaminhar precocemente à equipe de coluna; corticoide em altas doses não é rotina.

Referências pertinentes: R13.

QUESTÃO 41

Resposta: Viabilidade do músculo: quatro Cs - cor, consistência, contratilidade e circulação/sangramento.

Comentário: No desbridamento, músculo necrótico tende a estar escurecido, friável, não contrátil à estimulação e sem sangramento capilar; preservar tecido viável e reavaliar quando necessário.

QUESTÃO 42

Resposta: Atendimento de grande queimado pediátrico: ABCDE, via aérea, controle térmico e analgesia, cálculo da superfície queimada, reposição volêmica monitorizada e transferência para centro especializado.

Comentário: Estimativa de SCQ exclui eritema isolado de 1º grau; em queimaduras extensas, iniciar solução cristaloide titulada por diurese (em crianças geralmente alvo de 1 mL/kg/h) e acrescentar manutenção com glicose conforme idade/necessidade. Avaliar inalação de fumaça, lesões associadas e vacinação antitetânica.

Referências pertinentes: R11.

QUESTÃO 43

Resposta: Síndromes geriátricas incluem quedas/instabilidade, imobilidade, incontinências, comprometimento cognitivo/demência, delirium, fragilidade, sarcopenia, iatrogenia e polifarmácia.

Comentário: São condições frequentemente multifatoriais, inter-relacionadas e associadas a perda de autonomia. A lista varia conforme a classificação; depressão, disfagia e desnutrição também podem integrar a avaliação geriátrica.

Referências pertinentes: R14.

QUESTÃO 44

Resposta: Erosões marginais e osteopenia justa-articular, com possível redução uniforme do espaço articular.

Comentário: Poliartrite simétrica de pequenas articulações, rigidez prolongada, deformidades e FR positivo favorecem AR estabelecida. A expressão 'há pelo menos 5 minutos' é erro do texto e não deve alterar interpretação.

Referências pertinentes: R1.

QUESTÃO 45

Resposta: Hipótese principal: fibromialgia; tratamento multimodal.

Comentário: Dor difusa e sono alterado sem inflamação objetiva sugerem fibromialgia. Exercícios graduais, educação e manejo do sono são fundamentais; amitriptilina em baixa dose pode ser opção individualizada, mas não é obrigatória. Tender points não são exigidos pelos critérios atuais.

Referências pertinentes: R5.

QUESTÃO 46

Resposta: Espondiloartrite axial (possível espondilite anquilosante); radiografia da bacia/articulações sacroilíacas ou RM quando necessário.

Comentário: Lombalgia inflamatória em jovem favorece espondiloartrite. Radiografia de sacroilíacas pode revelar sacroileíte estrutural; RM detecta inflamação em doença não radiográfica. FABER não é específico para sacroileíte.

Referências pertinentes: R3.

QUESTÃO 47

Resposta: Gota crônica tofácea; confirmar quando possível e iniciar terapia redutora de urato, preferencialmente alopurinol.

Comentário: Nódulos, episódios clássicos e erosões em 'saca-bocado' favorecem gota tofácea. O alopurinol requer titulação por uricemia-alvo (<6 mg/dL) e profilaxia anti-inflamatória inicial, considerando função renal

e contraindicações.

Referências pertinentes: R4.

QUESTÃO 48

Resposta: Manobras de Phalen e Tinel sobre o nervo mediano.

Comentário: Parestesias nos três primeiros dedos sugerem síndrome do túnel do carpo. Manobras clínicas ajudam; eletroneuromiografia pode ser útil em dúvida diagnóstica ou pré-operatório selecionado.

QUESTÃO 49

Resposta: Nos critérios SLICC de 2012: mielite, alopecia não cicatricial e consumo de complemento (C3, C4 ou CH50 reduzidos).

Comentário: O conjunto realmente integra critérios de 2012; a classificação EULAR/ACR de 2019 possui estrutura diferente, com FAN como critério de entrada. Critérios classificatórios não substituem diagnóstico clínico.

Referências pertinentes: R20.

QUESTÃO 50

Resposta: Estreitamento do espaço articular, osteófitos marginais e esclerose subcondral.

Comentário: Em osteoartrite também podem ocorrer cistos subcondrais e deformidades; o estreitamento costuma ser assimétrico, conforme compartimento acometido.

Referências pertinentes: R17.

QUESTÃO 51

Resposta: Artrite reativa.

Comentário: Oligoartrite assimétrica após uretrite acompanhada de conjuntivite é apresentação sugestiva. Excluir artrite séptica, pesquisar infecção urogenital ativa e tratar sintomas/artropatia conforme gravidade.

Referências pertinentes: R15.

QUESTÃO 52

Resposta: Radiografias das mãos e ultrassonografia do ombro direito, se houver suspeita de tendinopatia do manguito.

Comentário: Quadro mecânico com nodulações interfalangeanas sugere artrose das mãos; dor de ombro requer exame físico e, se indicado, ultrassom para partes moles. Não há exame obrigatório universal sem melhor caracterização clínica.

QUESTÃO 53

Resposta: Primeiro tratar a provável crise aguda de gota com anti-inflamatório apropriado, após afastar artrite séptica.

Comentário: Monoartrite quente deve motivar consideração de artrocentese, especialmente antes de presumir gota. AINE, colchicina OU glicocorticoide são opções condicionadas às comorbidades; alopurinol é para prevenção de longo prazo quando indicado, podendo ser iniciado durante a crise com cobertura anti-inflamatória.

Referências pertinentes: R4.

QUESTÃO 54

Resposta: Investigar LES: FAN, anti-dsDNA, anti-Sm, C3/C4, hemograma, EAS/proteinúria e função renal; radiografia de tórax para pleurite.

Comentário: Mulher jovem com artrite, pleurite e antecedente hematológico sugere LES. Radiografia avalia derrame, mas não confirma autoimunidade; sorologias e órgãos-alvo definem o quadro.

Referências pertinentes: R2.

QUESTÃO 55

Resposta: Hanseníase, entre outros diagnósticos diferenciais.

Comentário: A hanseníase pode produzir poliartrite ou neurite e simular AR, particularmente em áreas endêmicas; investigar alterações de sensibilidade, nervos periféricos e lesões cutâneas.

QUESTÃO 56

Resposta: Baixo IMC e tabagismo.

Comentário: Também são fatores de risco envelhecimento, fratura por fragilidade, corticoterapia, baixa ingestão de cálcio, hipogonadismo, sedentarismo e antecedentes familiares, conforme contexto.

Referências pertinentes: R7.

QUESTÃO 57

Resposta: Teste de Phalen.

Comentário: A flexão sustentada do punho pode desencadear parestesias no território do nervo mediano na síndrome do túnel do carpo; teste isolado não é definitivo.

QUESTÃO 58

Resposta: Dor sacroilíaca pode sugerir sacroileíte, mas FABER não a confirma isoladamente.

Comentário: A localização da dor importa: posterior, na região sacroilíaca, favorece origem sacroilíaca; dor inguinal aponta para patologia do quadril. Teste clínico tem especificidade limitada.

QUESTÃO 59

Resposta: Erosões precoces, altos títulos de FR/anti-CCP e atividade inflamatória persistente ou extensa.

Comentário: Extenso número de articulações acometidas, incapacidade funcional, manifestações extra-articulares e PCR/VHS elevados sustentados também indicam pior prognóstico.

Referências pertinentes: R1.

QUESTÃO 60

Resposta: Anti-Sm (anti-Smith).

Comentário: É altamente específico para LES, embora pouco sensível. Anti-dsDNA também é útil, especialmente em avaliação de nefrite/atividade, mas não é exclusivo de todos os casos.

QUESTÃO 61

Resposta: Espondiloartrite axial/espondilite anquilosante com provável uveíte anterior aguda.

Comentário: Dor lombar inflamatória, entesite de calcâneo e olho doloroso com fotofobia sugerem espondiloartrite. Queixa ocular exige avaliação oftalmológica urgente.

Referências pertinentes: R3.

QUESTÃO 62

Resposta: Osteoartrite.

Comentário: Nódulos em interfalangeanas, crepitação em joelhos e dor relacionada a carga sugerem doença degenerativa, não poliartrite inflamatória ativa.

Referências pertinentes: R17.

QUESTÃO 63

Resposta: Controlar a crise aguda presumida de gota com AINE, colchicina ou corticosteroide, após avaliação de contraindicações e exclusão de infecção.

Comentário: A uricemia elevada apoia predisposição, mas não confirma a causa da monoartrite; se dúvida, analisar líquido sinovial. Revisar hidroclorotiazida se viável; alopurinol é prevenção, não analgésico da crise.

Referências pertinentes: R4.

QUESTÃO 64

Resposta: Artrite reumatoide.

Comentário: Poliartrite simétrica de pequenas articulações, rigidez prolongada, nódulo reumatoide, FR alto e erosões radiográficas caracterizam AR soropositiva erosiva.

Referências pertinentes: R1.

QUESTÃO 65

Resposta: Osteoartrite dos joelhos.

Comentário: Dor mecânica, obesidade, crepitações, osteófitos, esclerose subcondral e estreitamento do espaço articular são típicos.

Referências pertinentes: R17.

QUESTÃO 66

Resposta: Hidroxicloroquina, se confirmado LES e não houver contraindicações.

Comentário: Artrite, alopecia, úlceras, fotossensibilidade e FAN alto sugerem LES. Hidroxicloroquina é terapia basal, mas avaliar primeiro envolvimento renal/hematológico e dose/monitorização oftalmológica.

Referências pertinentes: R2.

QUESTÃO 67

Resposta: Provável crise aguda de gota; tratar com AINE, colchicina ou glicocorticoide conforme o perfil clínico.

Comentário: Monoartrite súbita de joelho com podagra prévia é sugestiva, mas infecção deve ser excluída. Associação AINE + colchicina não é obrigatória e pode aumentar toxicidade.

Referências pertinentes: R4.

QUESTÃO 68

Resposta: Tendão supraespinal, como hipótese mais provável.

Comentário: Dor no arco de elevação e testes de impacto podem envolver supraespinal; Neer é teste de impacto e não identifica isoladamente o tendão. Teste de Jobe e imagem, quando indicados, refinam o diagnóstico.

Referências pertinentes: R18.

QUESTÃO 69

Resposta: Tratamento antirreabsortivo, frequentemente bisfosfonato, e garantia de ingestão adequada de cálcio e vitamina D.

Comentário: A seleção depende do risco de fratura, função renal, tolerabilidade e outros fatores. Suplementar cálcio ou vitamina D somente se necessário para assegurar aporte e níveis adequados; medidas de quedas e exercício também são essenciais.

Referências pertinentes: R7, R19.

QUESTÃO 70

Resposta: Quadratura dos corpos vertebrais e sindesmófitos marginais; em doença avançada, coluna em bambu.

Comentário: Entesite vertebral e pontes ósseas podem causar anquilose e retificação das curvaturas da coluna.

Referências pertinentes: R3.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

Seleção de fontes científicas e diretrizes acessíveis para verificação. Os números R1–R20 identificam documentos efetivamente consultados durante a elaboração. As referências indicadas após as questões apontam o fundamento relacionado, mas não significam que o enunciado tenha sido retirado dessas fontes.

R1. ACR. Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis (2021).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

R2. EULAR. Recommendations for SLE treatment (2023).
https://ard.bmj.com/content/83/1/15

R3. ASAS-EULAR. Management of axial spondyloarthritis (2022).
https://ard.bmj.com/content/82/1/19

R4. ACR. Guideline for the Management of Gout (2020).
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.41247

R5. EULAR. Recommendations for Fibromyalgia (2017).
https://ard.bmj.com/content/76/2/318

R6. EWGSOP2. Sarcopenia: revised consensus (2019).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/

R7. NOGG. Clinical guideline for osteoporosis (2024).
https://www.nogg.org.uk/full-guideline/summary-main-recommendations

R8. International Osteoporosis Foundation. Exercise in osteoporosis.
https://www.osteoporosis.foundation/health-professionals/prevention/exercise/exercise-individuals-with-osteoporosis

R9. ACR/Arthritis Foundation. Osteoarthritis management guideline (2019).
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.41142

R10. Tissue expansion: histological changes (review).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3385404/

R11. American Burn Association. Burn depth and referral criteria.
https://www.ameriburn.org/burn-care-team/resources/guidelines-for-burn-patient-referral

R12. American College of Surgeons. Stop the Bleed, instructor manual (2025).
https://www.stopthebleed.org/media/pkpnanvp/acs-stop-the-bleed-version-30-instructor-guide.pdf

R13. NICE. Spinal metastases and cord compression (NG234).
https://www.nice.org.uk/guidance/ng234/chapter/recommendations

R14. WHO. Integrated Care for Older People, 2nd edition (2025).
https://www.who.int/publications/i/item/9789240103726

R15. EULAR. Pharmacological management of psoriatic arthritis (2023 update).
https://ard.bmj.com/content/83/6/706

R16. ACR. Glucocorticoid-induced osteoporosis guideline (2022/2023).
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.25240

R17. NICE. Osteoarthritis in over 16s: diagnosis (NG226).
https://www.nice.org.uk/guidance/NG226/chapter/recommendations

R18. AAOS. Achilles tendon rupture: clinical diagnosis.
https://www.aaos.org/aaosnow/2019/oct/research/research02

R19. NOGG. Osteoporosis: detailed anabolic and antiresorptive options.
https://www.nogg.org.uk/full-guideline/section-6-pharmacological-treatment-options

R20. EULAR/ACR. SLE classification 2019 (description and immunological criteria).
https://ard.bmj.com/content/78/9/1151

Nota técnica: trata-se de gabarito educacional fundamentado, não oficial. Diagnósticos e tratamentos mencionados em questões de prova dependem, na prática, de avaliação individual e de diretrizes atualizadas.